

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

*Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т.,
Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г.*

Городской онкологический диспансер,

*Казахский Национальный Медицинский Университет им.Асфендиярова,
Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан*

Использование системной химиотерапии как звено в комбинированном или комплексном лечении рака шейки матки (РШМ), по данным многих авторов, расширяет перспективы хирургического лечения местнораспространенных форм РШМ и улучшает отдаленные результаты.

Исследования были выполнены на базе Городского онкологического диспансера г. Алматы в период 2003 – 2009 гг. Объектом клинко-морфологических исследований были 147 больных первичным раком шейки матки IIa – III стадий по FIGO. По дизайну исследования 97 больным проведена неоадъювантная химиотерапия (НАПХТ) в режиме PF: цисплатин в дозировке 100 мг/м² 1-й день с использованием стандартного режима гипергидратации и антиэметиков и 5-фторурацил 750 мг/м² со 2-го по 5-й дни (внутривенно) (1-3 курса). После оценки эффективности лечения 47 больных (48,5%) (I группа) проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки с придатками и верхней трети влагалища, с последующим дистанционным облучением до суммарно очаговой дозы (СОД) 40 Гр. II-ю группу составили 50 больных, которым после завершения НАПХТ была проведена сочетанная лучевая терапия (СЛТ) по радикальной программе, СОД на т.А – 60-75 Гр, СД на т.В – 45-54 Гр. III группу – группу контроля, составили 50 пациенток с раком шейки матки, которым была проведена сочетанная лучевая терапия по радикальному курсу в условиях КазНИИОиР.

Согласно нашим наблюдениям эффективность при проведении различных видов противоопухолевой терапии была различной. Прежде всего, это было связано с первичной распространенностью опухолевого процесса, повлекшего за собой той или иной вариант лечения. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что одногодичная выживаемость составила 100% в группе больных, пролеченных комплексным лечением. В группах химиолучевой лечения и СЛТ годовой рубеж пере-

жили 94% и 92% соответственно. 3-х летний безрецидивный период в группе больных, пролеченных комплексным методом, составил 82,9%, после химиолучевой лечения – 70%, после СЛТ – 59%. Трехгодичная выживаемость в зависимости от вида лечения составила 85,1%, 74% и 62,0%. 5-летняя выживаемость в группе комплексного лечения достигла 78,7%, в группе комбинированного лечения – 60%, после СЛТ – 46%.

После проведенного первичного лечения в группе комбинированной и сочетано-лучевой терапии время до возникновения рецидива составило 6 месяцев. В группе первичного комплексного лечения время до прогрессирования составило 18 месяцев. В группе комплексного лечения без рецидивов и метастазов 2-летний рубеж пересекло 91,5% больных. Этот показатель в группе комбинированного и сочетано-лучевого лечения составил соответственно 78% и 64%. Всего показатель 2-х летней безрецидивной выживаемости составил 80,9%. В группе больных, которым была проведена комплексная терапия, рецидивы и отдаленные метастазы были выявлены в 1,3 и 1,8 раз реже по сравнению с больными после комбинированного и сочетано-лучевого лечения соответственно.

Результаты лечения рака шейки матки различными методами показали, что прогноз благоприятен лишь в ранних стадиях и ухудшается при распространении процесса. При инвазивном раке шейки матки в пределах T1b трехлетняя выживаемость отмечалась в 92,3%; при распространенности по FIGO IIA - в 88,9%; при IIB стадии - в 64,7%, при III стадии - в 55,9% случаях. Рецидивы и отдаленные метастазы были диагностированы среди больных раком шейки матки I степени у 15,4%, при IIa стадии – у 19,4%, при IIb стадии – 60,8%, III стадии - у 85,3%. Таким образом, применение системной химиотерапии в многокомпонентном лечении является эффективным методом лечения местнораспространенного рака шейки матки.

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИНГИБИТОРАМИ ЦОГ-2 С МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЦИТОСТАТИКОВ

Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Абенова М.Т., Жолдыбай Ж.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК г.Алматы

Городской онкологический диспансер г.Астаны

Рак шейки матки (РШМ) – визуально доступная форма опухоли. В исследовании клеточных мазков с поверхности шейки матки широко используют цитологический метод. Он является простым, безболезненным, сравнительно дешевым, малотравматичным, а его информативность довольно высока и составляет для преинвазивного рака - 80%, при РШМ Ia-Ib стадий - 85%, при инвазивном раке - 90%. Также в цитологии широко применяют пункционную биопсию, но при этом методе высок риск неточного попадания иглы в пунктируемую ткань. Для устранения этого момента и повышения точности диагностики используют сочетание направленной тонкоигольной пункционной биопсии с ультразвуковой эхографией. Одним из важных критериев оценки проводимой терапии явились результаты цитологического исследования степени лечебного патоморфоза в опухоли.

Цель работы - оценка лучевого патоморфоза РШМ на этапах сочетанной лучевой терапии (СЛТ) при радиосенсибилизации опухоли кетопрофеном (ингибитор фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2)) с малыми дозами цитостатика - 5-фторурацила (5-Фу). В исследование было включено 80 больных IIa-IIb стадий РШМ (по классификации FIGO), получивших лечение в Казахском НИИ онкологии и радиологии.

По способу лечения пациентки разделились на 2 группы: основная группа (n=40) - больные РШМ, получившие СЛТ на фоне радиомодификации с внутриопухолевым введением 5-Фу (250мг х ч/день, №5) в сочетании с пероральным приемом кетопрофена (50мг х 2 р/день, №25); контрольная группа (n=40) - больные РШМ, получившие только СЛТ по радикальной программе.

Результаты цитологии оценивались в динамике лечения

(при дозе облучения 20Гр и после завершения всей терапии). Материалом исследования послужили мазки, взятые с поверхности опухоли шейки матки и мазки, полученные при направленной тонкоигольной пункционной биопсии (из центральных зон опухоли) при помощи биопсийной системы – пружинный пистолет «Bard Magnum». Степень повреждения клеточных элементов опухоли определялась по морфологической классификации Г.А. Лавниковой на специальном оборудовании (программный аппаратный комплекс «Leica DMSL») с увеличением $\times 400$ и $\times 1000$. Окраска материала проводилась по способам Романовского-Гимза и Паппенгейма.

Установлено, что в основной группе при начальной дозе облучения (20Гр) отмечалось преимущественное повреждение опухолевых клеток II (42,5% - в пункционном материале) и III степени (42,5% - в поверхностных мазках), а после завершения

лечения - IV степени (85,0% - в поверхностных мазках и 82,5% - в пункционном материале). В контроле при 20Гр чаще отмечалось радиационное повреждение опухолевых клеток I (по 47,5% - в поверхностных мазках и в пункционном материале), а после завершения СЛТ - преимущественно IV степени (по 55,0% - в поверхностных мазках и в пункционном материале). Итак, в обеих группах наблюдалась схожая тенденция усиления повреждения клеток опухоли по мере нарастания дозы ионизирующей радиации к концу проводимой терапии. Однако в основной группе в опухоли патоморфоз IV степени наблюдался в 1,5 раза чаще, чем в контроле, что свидетельствовало об усилении радиационного повреждения опухоли шейки матки при применении полирадиомодификаторов в основной группе.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АСҚАЗАН РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жұмағали Д.Ж., Орманов Н.К., Мадилоходжаев Р.С.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, дүниежүзінде асқазан рагі (АР) қатерлі ісік аурулары арасында екпе рагінен соң екінші орындарды алады және бір жылда 1 млн. астам науқастар осы аурудан көз жұмады. Ал Қазақстан Республикасында 2010 жылы асқазан рагі 100 мың халыққа шаққанда 16,3 көрсетіп төртінші орынды алса, ал ең жоғарғы көрсеткіш Солтүстік Қазақстан (24,0), Ақмола (22,1), Шығыс Қазақстан (22,0) облыстарында орын алып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында соңғы жылдарда сүт безі рагі алғашқы орында келсе, ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагі бірінші орынға шыққан және де алғаш рет анықталғандардың 17,5 пайызы ғана бірінші-екінші сатысында анықталса 25,4 пайызы төртінші сатысында анықталған. Осы мерзімде қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), Сондықтан, қазіргі таңда ғылыми сарапталған жаңа әдістері асқазан ісік алды және ісік ауруларының алдын алуда маңызды орын алуы тиіс.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша асқазан рагінің эпидемиологиялық жағдайын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығында және 2011 жылдың 7 айындағы алғашқы рет асқазан рагімен тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35,7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы санитарлық статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2010 жылы 2390 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде асқазан рагімен 266 науқас тіркеліп, сүт безі рагінен соң екінші орында болатын. Оларды жынысына қарап бөлгенде 162 ер кісі (60,9 пайыз), ал 104 әйел кісі (39,1 пайыз). Аурушандық деңгейі де кейінгі жылдарда төмендеу байқалған, атап айтқанда 2006–2010 жылдар 100 000 халыққа шаққанда 13,2 ден 10,4 азайған. Ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагімен 212 науқас диспансерлік есепке алғаш рет алынған

және бірінші орынға шыққан. Асқазан рагімен анықталғандарды жасына қарап бөлсе, 2006 жылы 15-50 жаста 36 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 50 науқас (18,2 пайыз), 60-70 жаста 97 науқас (35,2 пайыз), 70-80 жаста 81 науқас (29,4 пайыз), 81 жас және жоғары 10 науқас (3,6 пайыз), салыстырмалы 2010 жылы 15-50 жаста 35 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 53 науқас (19,9 пайыз), 60-70 жаста 94 науқас (35,3 пайыз), 70-80 жаста 66 науқас (24,8 пайыз), 81 жас және жоғары 17 науқас (6,3 пайыз) болған. Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2006 жылы 16,7 пайыз, ал 2010 жылы 16,8 пайыз айтарлықтай кейінгі бес жылда алға үлгерілеу байқалмайды, асқынған төртінші сатысында 2006 жылы 25,4 болса, 2010 жылы 25,1 азаймаған. Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2006 жылы 27,1 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2010 жылы 26,7 айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бір жылдық өлім асқазан рагінен 2006 жылы 36,7 пайыз (772 науқас), 2010 жылы 29,7 пайызға төмендеген.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2006 жылы 133 науқас 23,3 пайыз болса, ал 2010 жылы 279 науқас 41,2 пайызға өскен, бірақ бұл төмен көрсеткіш.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, асқазан рагінің статистикалық көрсеткіштерінің өзгеріссіз қалыпты деңгейде қалуы, бұл мәселенің шешілмей келе жатқандығын көрсетеді. Арнайы емнің толық жүргізілуі өз нәтижесін бергеніне қарамастан асқазан рагі ерте анықталмай, асқынған кезеңде кеш анықталуы негізгі мәселе. Бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде асқазан рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға, 5 жыл және одан артық өмір сүруін арттыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындау маңызды орын алады, ал өңеш, асқазан және ішек жолдарына скринингтік профилактикалық тексеру енгізу, бұл өмір талабы.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНАН ҚАЙТЫС БОЛУ ЖАҒДАЙЫ

Д.Ж.Жұмағали

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңдағы қоғамда онкологиялық аурулар мәселесі маңызды болып табылып, дүниежүзі ғалымдарын осы мәселені қалай шешу керектігі ойландыруда. Атап айтқанда, дүниежүзінде жылда 9 млн. адам өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке онкологиялық

аурулармен алынса, 5 млн адам жылына қайтыс болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша 2020 жылы онкологиялық аурулармен өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке алынғандар саны 20 000 000 жетсе, ал қайтыс болғандар саны 12 000 000 асады делінген. Осыған

қарамастан Қазақстанда онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар соңғы бес жылда 100 000 халыққа шаққанда 115,0 ден 104,0 дейін төмендеген, ал Оңтүстік Қазақстан облысы бойыншада 2006 жылы 60,1 болса, ал 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Бірақ соңғы 2009-2010 жылдарда облыс көлемінде онкологиялық аурулардың аурушандығының өсімі байқалады, демек жалпы өлім санының өсуі белең алуы мүмкін.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық аурулардан қайтыс болуын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығы мен 2011 жылдың 7 айындағы сапалы көрсеткіштердің бірі онкологиялық аурулардан қайтыс болғандарды тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35, 7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2006 жылы онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар саны болса, оны 100 000 халыққа шаққанда 60,1 болған. Бұл көрсеткіш 2007 жылы 63,7 дейін өскен, бірақ 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Ал 2011 жылдың 7 айында 803 науқас қайтыс болса, 100 000 халыққа шаққанда 31,6 ал 2010 жылдың 7 айында 733 науқас қайтыс болған 30,4, салыстырмалы алғанда 1,4 өсім байқалады. Осы анықталған 803 науқастың 153 науқас бір жылға дейін (19,05 пайызы) қайтыс болса, 650 науқас бір жылдан асқан соң қайтыс болған. Оларды жасына қарап бөлгенде 41-60 жас аралығында 29,4 пайызы (235 науқас), 61-70 жаста 28,1 пайызы (225 науқас), 71 жастан жоғары 34 пайыз (273 науқас) құраған. Ал сатыға

бөлгенде екінші сатысында 93 науқас (11,5 пайыз), үшінші сатысында 425 науқас (53,0 пайыз), төртінші сатысында 276 науқас (34,5 пайыз) болған. Екінші жағдайдағы 650 науқастың екі жылға дейін 367 қайтыс болған (56,4 пайызы). Қатерлі ісіктің орналасуына қарап қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), екінші орында өңеш рагі 109 науқас (13,5 пайыз), үшінші орында өкпе рагі 83 науқас (10,3 пайыз), төртінші орында ұйқы безі рагі 78 науқас (9,7 пайыз), бесінші орында бауыр рагі 67 науқас (8,3 пайыз) болған.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, жалпы өлім 2011 жылдың 7 айында 100 000 халыққа шаққанда 1,4 өскен, ал қайтыс болған науқастардың 62,1 пайызы 61 жастан асқандар болса, олардың 74,5 пайызы екі жылға дейін қайтыс болғандар, демек кеш анықталуы және де орналасуына қарап 63 пайызы негізгі асқазан, өңеш, өкпе, ұйқы безі, бауыр рактерінен, ал аурушандықтың өсуімен қатар өлімнің өсуі, бұлда заңдылық. Осыған қарамастан скринингтік профилактикалық тексерулер нәтижесін беріп жатқанда, жоғары да аталған негізгі орналасуларда да скринингтік профилактикалық тексеру 50 жастан жоғары жүргізілсе. Онда ерте кезеңде анықтап, арнайы ем толық жүргізілсе және де бастапқы медициналық санитарлық деңгейде керекті мамандармен қамтып, қосалқы қазіргі заманғы жаңа құралдармен толықтырылса (рентгендік, ЭФГДС, УДҚ) өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Осы тұрғыда, бұл мәселе 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындауда маңызды орын алатынына күмәнім жоқ.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ

Жумабаев А.Р., Гапырова Г.М.

Ошский межобластной центр онкологии, г. Ош Кыргызская Республика

Актуальность. До 90% больных со злокачественными новообразованиями печени не получают радикального хирургического лечения в связи с поздней диагностикой. Если принять во внимание тот факт, что большинство больных хотели бы провести остаток своей жизни и умереть дома (от 80 до 90 % опрошенных нами пациентов), то оказание паллиативной помощи в домашних условиях было бы наиболее целесообразно.

Цель исследования: определение потребности оказания паллиативной помощи пациентам с инкурабельными злокачественными новообразованиями печени жителей г. Ош.

Материал и методы исследования: Пилотным регионом был выбран город Ош, где, а с 2004 по 2006 год зарегистрировано 41 больных первичным раком печени, которым проведена комплексная терапия. Средний возраст 61,5 лет (от 38 до лет 85). Анкеты-вопросники заполнялись как во время первичного осмотра пациентов на консультативном приеме в амбулаторно-диагностическом отделении Ошского межобластного центра онкологии, так и во время осмотра онкологических больных на дому. Первичным намерением анкетирования было выяснение преобладающих симптомов болезни среди онкологических больных, их нуждаемости в паллиативной помощи, в доступности медицинских и социальных ресурсов.

Результаты и обсуждения: по полученным анкетным данным установлено, что у пациентов отмечались следующие симптомы: боль 38 случаев, слабость - 26 случаев, бессонница - 9 случаев, беспокойство и депрессия - 9 случаев, раздражительность и тревога - 9 случаев, похудание и потеря аппетита - 23 случаев, тошнота - 13 случаев, рвота - 8 случаев, одышка - 9 случаев, запоры - 13 случаев, диарея - 3 случая, кожный зуд - 6 случаев, желтуха - 7, пролежни - 7 и асцит - 12 случаев. Слабый симптом был оценен в 1 балл, умеренный - в 2 бал-

ла, сильный - в 3 балла. Для оценки тяжести испытываемых пациентом симптомов, общая оценка каждого симптома была суммирована и получены следующие результаты: боль - 83, слабость - 98, бессонница - 12, беспокойство и депрессия - 32, раздражительность и тревога - 20 у, похудание и потеря аппетита - 40, тошнота - 27, рвота - 14, одышка - 22, запоры - 24, диарея - 7, кожный зуд - 13, желтуха - 19, пролежни - 17, асцит - 25 баллов.

Боль явилась наиболее частым симптомом у пациентов первичным раком печени в терминальной стадии заболевания. Лечение хронической боли проводилось согласно анальгетической трехступенчатой схемы по ВОЗ (1999): ацетилсалициловая кислота по 250 мг пациентам (слабая боль), 29 пациентам (сильная боль) - трамадол гидрохлорид по 50 мг 4 раза в сутки и нестероидные противовоспалительные средства (индометацин, ибупрофен), 3 пациентам - морфин гидрохлорид по 20 мг 4 раза в сутки. Из вспомогательных лекарственных препаратов был использован дексаметазон по 4-6 мг с последующим поэтапным снижением (через неделю) до уровня поддерживающей 5-10 мг (дексаметазон 1-2 мг); карбамазепин по 100 мг 2 раза в день; амитриптилин по 25 мг 1 раз в сутки на ночь, при неэффективности анальгетического эффекта у 2 пациентов через 3 дня доза была повышена до 50 мг, затем до 75 мг.

Выводы: случаи боли у онкологических пациентов (92,7%) с терминальными стадиями развития болезни соответствовали данным, процитированным ВОЗ (80%). Полноценную помощь удалось оказать 78,01% пациентам. Доля пациентов, чью боль не удалось купировать несмотря на назначенное лечение, составила 12,19%. Осталось неизвестным состояние - у 4 (9,80%) пациентов, ввиду отсутствия достоверных сведений.